

CMC 8 – Comment bien présenter un cas à son/sa superviseur-e

Unité : Intégration

Objectifs :

- Connaître la structure d'une présentation de cas
- Repérer les éléments pertinents à mentionner dans une présentation cas
- Pratiquer la présentation de cas
- Décrire un outil (SNAPPS) permettant d'articuler la présentation de cas avec le processus de raisonnement clinique

Méthode

- Travail en groupe
- Observation de vidéos
- Jeux de rôle

1. Organisation de la présentation

PRÉSENTATION DE CAS
Structure et contenu
Présentation de la plainte principale Nom, âge, sexe, plainte principale, antécédents pertinents en lien avec la plainte principale
Anamnèse actuelle Détails de la plainte/douleur Éléments clés dans un ordre chronologique Intégration de l'AVIS (attente, vécu, impact) Intégration des antécédents personnels, familiaux, psychosociaux en lien avec la plainte principale Anamnèse des systèmes pertinents
Antécédents médicaux pertinents Médication – doses et fréquence de prise Allergie Antécédents familiaux pertinents Habitudes Éléments psychosociaux pertinents
Examen physique Apparence générale et signes vitaux Présentation systématique (tête à pied) Degré de détails approprié pour chaque système (éléments positifs et négatifs) Description des systèmes pertinents et exclusion des autres systèmes
Résumé Synthèse des éléments pertinents de l'anamnèse et de l'examen physique (résumé)
Formulation de 3 hypothèses diagnostiques (en ayant les arguments pour et contre chaque hypothèses prêts)
Plan (en ayant les arguments prêts pour chaque suggestion)

2. Guide pour stimuler votre raisonnement clinique (SNAPPS) à la fin de la présentation de cas

S	1. Summarize : faire résumer brièvement l'anamnèse et l'examen physique
N	2. Narrow : cibler les 2 ou 3 hypothèses diagnostiques les plus probables
A	3. Analyse : analyser les arguments pour et contre chaque hypothèse
P	4. Plan : formuler un plan pour la suite de la prise en charge du problème du patient
P	5. Probe : préparer une question à poser au/à la superviseur-e (incertitudes, difficultés et approches alternatives)
S	6. Select : sélectionner un thème à approfondir dans des lectures personnelles

Références

- Green EH, DeCherrie L, Fagan MJ, Sharpe BA, Hershman W. The oral case presentation: what internal medicine clinician-teachers expect from clinical clerks. Teach Learn Med. 2011 Jan;23(1):58-61. doi: 10.1080/10401334.2011.536894.
- Green EH, Hershman W, DeCherrie L, Greenwald J, Torres-Finnerty N, Wahi-Gururaj S. Developing and implementing universal guidelines for oral patient presentation skills. Teach Learn Med. 2005 Summer;17(3):263-7.
- Wolpaw TM, Wolpaw DR, Papp KK SNAPPS: a learner-centered model for outpatient education. Acad Med. 2003 Sep;78(9):893-8.
- <https://www.mededportal.org/publication/10017/>